GUIDE COMPLET

Levez les Freins *qui Bloquent Votre Carrière*

Comprendre ce qui freine votre évolution, et des pistes concrètes pour avancer.



Alain Zenatti
Hypnothérapeute
NovaHypnose · Paris 4e · novahypnose.fr

AU PROGRAMME

Six chapitres, *une idée simple*

Syndrome de l'imposteur, auto-sabotage, peur de progresser : comprendre ces mécanismes de protection, repérer le vôtre, et essayer des outils concrets.

01 Pourquoi ces blocages ne sont pas rationnels

02 Les 3 profils des freins de carrière

03 Pourquoi « avoir confiance » ou « positiver » ne suffit pas

04 Ce que la science dit de l'hypnose et de la confiance en soi

05 Votre programme pratique : désamorcer les freins inconscients

06 Quand consulter ? Ce que l'hypnothérapie peut faire pour vous

AVANT DE COMMENCER

Ce guide propose des pistes de réflexion. Il ne remplace ni un avis médical ni un suivi psychologique ou psychiatrique. En cas de détresse, appelez le 3114 (numéro national de prévention du suicide).

INTRODUCTION

Des peurs irréelles aux conséquences bien réelles

Vous avez les compétences, l'expérience, les idées. Vous savez ce que vous devriez faire pour avancer. Et pourtant, une résistance inexplicable vous empêche de franchir le pas.

Ces blocages ne sont pas de la paresse ou un manque d'ambition. Ce sont souvent des croyances inconscientes sur ce que vous méritez, ce que vous êtes capable d'accomplir, ce qui pourrait arriver si vous réussissez. Votre inconscient vous protège d'une menace imaginaire, au prix de votre progression réelle.

> *« L'hypnose dialogue avec ces croyances pour les faire évoluer. Vos compétences peuvent alors s'exprimer avec moins d'opposition intérieure. »*
>
> Alain Zenatti

9 à 82 %

des personnes présenteraient des signes du syndrome de l'imposteur, selon l'outil de mesure (synthèse de 62 études, Bravata et al., 2020)

15-20 %

des adultes seraient des procrastinateurs chroniques (communiqué de l'Université de Calgary sur l'étude de Steel, 2007)

25 %

des salariés français jugent leur santé mentale mauvaise ou très mauvaise (baromètre Qualisocial-Ipsos, décembre 2024, 3 000 salariés)

Trois chiffres, trois échelles différentes : une synthèse internationale de la recherche clinique, une méta-analyse académique, un baromètre français de terrain. Ce qu'ils indiquent ensemble : le sentiment de ne pas être à la hauteur, malgré des preuves du contraire, n'est ni rare ni marginal.

La bonne nouvelle : ces blocages ne sont pas des traits de personnalité figés. Ce sont largement des schémas appris, et ce qui s'apprend peut se réapprendre.

CHAPITRE

01

Pourquoi ces blocages *ne sont pas rationnels*

Votre cerveau ne fait pas toujours la différence entre un danger physique et une menace sociale. C'est là que tout commence.

Le cerveau ne distingue pas toujours réussir et être en danger

Le système d'alarme du cerveau, piloté par l'amygdale, a évolué pour détecter des menaces physiques : un prédateur, une chute, une blessure. Mais il traite de façon proche certaines menaces purement sociales : être vu, être jugé, être exposé, voir ses relations changer. Une promotion, une prise de parole publique, une augmentation de visibilité peuvent déclencher la même alarme qu'un danger réel, alors qu'objectivement, rien ne vous menace.

Ce mécanisme explique pourquoi la peur de progresser cède rarement face aux arguments rationnels : elle n'est pas logée dans la partie du cerveau qui raisonne, mais dans celle qui alerte.

L'homéostasie psychique : pourquoi le connu rassure, même inconfortable

Le corps maintient sa température, son taux de sucre, son équilibre interne par homéostasie. Le psychisme fonctionnerait selon une logique similaire : l'inconscient tend à préserver l'équilibre actuel, même insatisfaisant, plutôt que de risquer l'inconnu, fût-il meilleur. Rester au même poste, ne pas répondre à cette offre, remettre ce projet à plus tard : autant de façons de rester dans une zone connue, là où le succès représenterait une rupture d'équilibre, donc un risque perçu.

Le syndrome de l'imposteur, décrit dès 1978

En 1978, les psychologues Pauline Clance et Suzanne Imes ont décrit, chez des femmes à haut niveau de réussite, un phénomène qu'elles ont appelé le « syndrome de l'imposteur » : l'incapacité persistante à s'attribuer intérieurement son propre succès, malgré des preuves objectives de compétence. La personne attribue sa réussite à la chance, au hasard, ou à un effort qu'elle juge excessif, jamais à sa capacité réelle.

Clance a ensuite décrit un « cycle de l'imposteur » qui se répète à chaque nouvelle tâche : anxiété face au défi, sur-préparation ou procrastination, succès obtenu, soulagement mais attribué à la chance ou au surtravail plutôt qu'à la compétence, et le cycle recommence.

L'auto-sabotage : une stratégie de protection, pas un manque de volonté

Une étude expérimentale de référence (Berglas & Jones, 1978) a montré que, face à un succès perçu comme immérité ou incertain, une partie des participants préférait choisir volontairement un handicap à sa propre performance, plutôt que de risquer un échec qui remettrait en cause leur compétence. En se donnant par avance une excuse extérieure, ils protégeaient une image de soi fragile.

Ce mécanisme, appelé « auto-handicap » (*self-handicapping*), éclaire des comportements très concrets : repousser une échéance importante, arriver en retard à un entretien décisif, se disperser juste avant un enjeu clé. Ce ne sont pas des accidents : ce sont, sans que l'on en ait toujours conscience, des façons de garder le contrôle sur le récit de l'échec.

À RETENIR

Ces blocages ne sont pas un défaut de caractère : ce sont des mécanismes de protection décrits depuis plus de quarante ans en psychologie. Le cerveau peut confondre menace sociale et danger réel, l'inconscient peut préférer le connu inconfortable à l'inconnu prometteur, et certains comportements d'échec sont des stratégies de protection de l'image de soi.

CHAPITRE

02

Les 3 profils *des freins de carrière*

Ces blocages prennent des formes différentes. Les distinguer aide à cibler le bon levier de changement.

Profil	Ce que vous ressentez	Ce que cela révèle
1. Le syndrome de l'imposteur	Vous minimisez vos réussites, les attribuez à la chance ou au hasard, et redoutez d'être « démasqué(e) » à la prochaine occasion.	La compétence réelle n'a jamais été le problème : c'est son intégration intérieure qui fait défaut.
2. L'auto-sabotage actif	Vous repoussez, oubliez, ou compliquez sans le vouloir les étapes qui vous rapprocheraient d'un enjeu important.	Un comportement de protection contre un échec qui viendrait confirmer une crainte plus profonde.
3. La peur de progresser	L'idée d'être plus visible, plus reconnu(e), plus exposé(e) déclenche un malaise plus fort que l'enthousiasme attendu.	La réussite menacerait un équilibre relationnel ou identitaire auquel vous tenez, même inconsciemment.

Le syndrome de l'imposteur a aussi plusieurs visages

La psychologue Valerie Young a identifié cinq façons de vivre le syndrome de l'imposteur, cinq définitions inconscientes de ce que « être compétent » signifie : la Perfectionniste (une seule erreur efface tout le reste), l'Experte (il faut tout savoir avant d'agir), la Solitaire (demander de l'aide serait un aveu d'incompétence), la Génie naturelle (si ça demande un effort visible, ce n'est pas mérité) et la Superhéroïne (être compétent, c'est exceller sur tous les fronts à la fois) (Young, 2011).

Un mot sur la « peur du succès »

Le concept de « peur du succès » a été proposé dès 1968 par la psychologue Matina Horner. Sa formulation initiale a depuis été largement débattue et révisée par la recherche, qui n'a pas toujours reproduit ses résultats à l'identique. Ce qui reste solide aujourd'hui, c'est l'observation clinique répétée : pour certaines personnes, la perspective concrète de réussir déclenche une appréhension réelle, liée à la peur de perdre certains liens, ou de devoir maintenir un niveau d'exigence perçu comme écrasant.

À RETENIR

La plupart des personnes concernées combinent plusieurs profils selon le contexte. L'objectif n'est pas de choisir une étiquette, mais de repérer ce qui, chez vous, active le frein, pour travailler sur la croyance précise plutôt que sur un vague manque de confiance.

CHAPITRE

03

Pourquoi « avoir confiance » ou « positiver » *ne suffit pas*

Le conseil le plus répété, « crois en toi », « pense positif », s'adresse à la partie consciente de votre esprit. Les mécanismes décrits plus haut opèrent ailleurs.

Le mythe du perfectionnisme coupable

La croyance populaire veut que le perfectionnisme soit la cause principale de la procrastination et de l'auto-sabotage. La plus vaste méta-analyse menée sur la procrastination, portant sur 691 corrélations, montre que ce lien est en réalité faible. Les prédicteurs les plus solides sont ailleurs : l'aversion pour la tâche elle-même, un faible sentiment d'efficacité personnelle, et l'impulsivité (Steel, 2007).

Cette nuance compte : « lâcher prise sur la perfection » ne suffit pas toujours à débloquer l'action, parce que ce n'est souvent pas le mécanisme principal en cause.

Pourquoi la volonté consciente ne suffit pas toujours

L'étude de Berglas et Jones est éclairante : les participants qui s'auto-handicapaient ne le faisaient pas par manque de volonté consciente, ils étaient capables de réussir. Le mécanisme de protection opérait indépendamment de leur intention affichée. On ne peut pas « décider » de ne plus s'auto-saboter comme on décide de se lever plus tôt : le comportement protège quelque chose que la conscience ne voit pas directement.

Ce qui aide davantage : travailler sur la croyance, pas sur le symptôme

Les approches qui obtiennent des résultats sur ces blocages ne consistent pas à répéter des affirmations positives, mais à identifier la croyance ou l'association spécifique en jeu, puis à la retravailler directement, à un niveau qui échappe souvent à la volonté consciente. C'est le terrain de travail de l'hypnose ericksonienne, comme de plusieurs approches psychothérapeutiques.

À RETENIR

Le perfectionnisme n'explique qu'une partie du problème, contrairement à une idée reçue très répandue. Le levier est souvent ailleurs : les croyances inconscientes et les mécanismes de protection qui échappent à la volonté.

CHAPITRE

04

Ce que la science dit *de l'hypnose et de la confiance en soi*

Comme pour les autres guides, il est important de distinguer ce qui est solidement établi de ce qui reste moins documenté.

Ce qui se passe dans le cerveau pendant l'hypnose

Une étude de neuro-imagerie de l'équipe du Dr David Spiegel (Stanford), portant sur 57 personnes, a montré que chez les sujets hautement hypnotisables, l'état hypnotique s'accompagne d'une baisse d'activité du réseau cérébral de la saillance (ce qui gère l'inquiétude et l'attention aux menaces), d'une meilleure connexion entre le cortex préfrontal et l'insula (la communication corps-cerveau), et d'une connexion réduite avec le réseau du mode par défaut, associé à l'auto-évaluation critique (Jiang et al., 2017).

Ce mécanisme est pertinent ici : moins de rumination auto-critique, plus d'accès à un vécu corporel de sécurité, un espace dans lequel une croyance limitante peut être approchée autrement qu'en la combattant frontalement.

Le renforcement du moi (« ego-strengthening ») en hypnose

Dès 1971, le médecin britannique John Hartland a formalisé une technique de suggestion hypnotique visant à renforcer la confiance, l'autonomie et le sentiment de compétence : la procédure de « renforcement du moi », depuis enseignée en hypnothérapie clinique.

Une étude de Lavertue, Kumar et Pekala (2002) a comparé une hypnose de renforcement du moi à une relaxation progressive : les participants des deux groupes ont rapporté une amélioration de l'estime de soi et de la dépression. On ne peut donc pas attribuer ce progrès à l'hypnose elle-même.

HONNÊTETÉ SCIENTIFIQUE

Il n'existe pas, à ce jour, de grand essai contrôlé randomisé testant spécifiquement « l'hypnose contre le syndrome de l'imposteur » ou « contre l'auto-sabotage ». Ce chapitre s'appuie sur trois éléments distincts : le mécanisme cérébral général de l'hypnose (Spiegel et al.), une technique de renforcement de la confiance utilisée depuis plus de 50 ans en clinique (Hartland), et des études de taille modeste sur cette technique, dont les auteurs signalent eux-mêmes les limites. C'est un socle raisonnable, pas une preuve définitive.

CHAPITRE

05

Votre programme pratique : *désamorcer les freins inconscients*

Ces étapes ne visent pas à « forcer » la confiance : elles visent à rendre visible ce qui agit, pour l'instant, sans votre accord conscient.

Étape 1 : identifier votre profil dominant

Reprenez les 5 types de compétence du chapitre 2 (Perfectionniste, Experte, Solitaire, Génie naturelle, Superhéroïne). Lequel définit, sans que vous l'ayez choisi, ce que « être compétent(e) » signifie pour vous ? Cette règle implicite est souvent la première chose à assouplir.

Étape 2 : tenir un « dossier de preuves »

Le cycle de l'imposteur se nourrit du fait que chaque réussite est aussitôt oubliée ou réattribuée à la chance. Notez, chaque semaine, une réussite concrète et ce qu'elle a exigé de vous en compétence réelle, pas en chance, pas en surtravail. Relisez ce dossier avant chaque situation où le doute est susceptible de monter.

Étape 3 : nommer l'auto-sabotage sans se juger

La prochaine fois qu'une échéance importante se retrouve mystérieusement compliquée (retard, oubli, dispute, distraction), notez simplement : « Ceci pourrait être un auto-handicap. » Vous n'avez rien à corriger sur le moment. Le repérage, répété, retire au mécanisme une partie de son automatisme.

Étape 4 : pratiquer l'auto-compassion, pas l'auto-complaisance

La chercheuse Kristin Neff définit l'auto-compassion par trois composantes : la bienveillance envers soi-même plutôt que l'autocritique face à l'échec, la reconnaissance que l'imperfection fait partie de l'expérience humaine commune, et une attention équilibrée à ce que l'on ressent, sans s'y noyer. Contrairement à une crainte répandue, la recherche suggère que l'auto-compassion n'affaiblit pas la motivation : elle réduit la peur de l'échec qui alimente l'évitement (Neff, 2003 ; Neff, 2023).

Étape 5 : l'ancrage de confiance par l'auto-hypnose

En dehors des moments de doute, entraînez un ancrage : un geste discret associé à un souvenir précis où votre compétence a été pleinement reconnue et vécue comme légitime, pas comme de la chance. Construit en état de relaxation et répété régulièrement, ce geste peut ensuite être réactivé juste avant une situation exigeante, pour rappeler au corps un état différent du doute.

Auto-évaluation indicative

Cette grille n'est pas un outil clinique validé : elle s'inspire de concepts reconnus dans la recherche (cycle de l'imposteur, auto-handicap, peur de la visibilité) pour vous aider à situer où vous en êtes.

Question	0 point	1 point	2 points
Attribuez-vous vos réussites surtout à la chance, au timing, ou au fait que « la barre était basse » ?	Rarement	Parfois	Souvent
Repoussez-vous une candidature, une prise de parole ou un projet malgré les compétences requises ?	Rarement	Parfois	Souvent
Vous arrive-t-il de saboter une échéance importante (retard, oubli, conflit) juste avant un enjeu clé ?	Non	Parfois	Souvent
La perspective d'être davantage vu(e), reconnu(e) ou promu(e) déclenche-t-elle un malaise plus qu'un enthousiasme ?	Non	Un peu	Beaucoup
Après une réussite, la crainte d'être « démasqué(e) » à la prochaine occasion apparaît-elle ?	Non	Parfois	Souvent

Interprétation indicative :

- Score de 0 à 3 : freins ponctuels, probablement gérables avec les outils de ce chapitre.
- Score de 4 à 6 : schéma installé qui limite déjà vos choix professionnels. Un accompagnement peut accélérer le changement.
- Score de 7 à 10 : frein structurant qui pèse sur votre trajectoire depuis longtemps. Un accompagnement est recommandé.

CHAPITRE

06

Quand consulter ? *Ce que l'hypnothérapie peut faire pour vous*

Les outils de ce guide sont utiles au quotidien. Mais une croyance installée depuis des années se dénoue rarement seule : un accompagnement ciblé permet d'aller plus directement à la racine.

CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ EN PREMIER SI

Ce blocage s'accompagne d'un épisode dépressif marqué, d'un épuisement professionnel (burnout) déjà installé, ou d'une anxiété sévère qui déborde largement le cadre professionnel. L'hypnothérapie vient en complément d'un suivi médical ou psychologique, jamais en remplacement.

Ce qu'une séance d'hypnothérapie peut apporter

- identifier la croyance précise à l'œuvre derrière le blocage (« je ne mérite pas », « je vais être démasqué(e) », « réussir va m'isoler ») ;
- travailler, en état hypnotique, sur l'origine de cette croyance et sur les associations qui la maintiennent active ;
- installer un renforcement du moi (protocole inspiré de Hartland) pour consolider un sentiment de compétence stable, indépendant du dernier résultat obtenu ;
- construire un ancrage corporel de confiance, mobilisable avant une situation exigeante (entretien, prise de parole, négociation) ;
- faire la part entre exigence légitime et perfectionnisme paralysant, entre prudence saine et auto-sabotage.

À quoi s'attendre

Un accompagnement pour lever un frein de carrière se déroule souvent sur 3 à 5 séances. La première séance est la plus longue : environ 1 h 30, avec un temps d'échange approfondi (anamnèse) et un premier travail hypnotique. Les séances suivantes consolident et ciblent des situations professionnelles précises.

Je ne peux pas vous promettre de résultat. Mon engagement : si après 2 ou 3 séances rien n'a bougé pour vous, je vous le dis franchement, et je ne vous propose pas de continuer.

Tarif : première séance de 1 h 30, 90 €. Séances suivantes : 1 heure, 90 €. En présentiel à Paris 4e, ou en visioconférence depuis toute la France : un endroit calme, un casque et une connexion stable suffisent.

CONCLUSION

Vos compétences n'attendent plus que votre autorisation intérieure

Vous avez maintenant une compréhension plus claire de ce qui peut bloquer votre progression : non pas un manque de compétence, mais des mécanismes de protection inconscients, décrits par la recherche, et qui peuvent évoluer.

L'ESSENTIEL À RETENIR

- Le syndrome de l'imposteur et l'auto-sabotage sont des mécanismes de protection décrits depuis les années 1970, pas des défauts de caractère.
- Le perfectionnisme n'est pas, contrairement à une idée reçue, le principal moteur de la procrastination.
- La volonté consciente ne suffit pas toujours à désamorcer un mécanisme qui opère en dehors d'elle.
- La première étape concrète : identifier, dès aujourd'hui, votre profil dominant parmi les 5 types de compétence.

> *« Vos compétences ont toujours été là. Il ne leur manquait que la permission intérieure de s'exprimer pleinement. »*
>
> Alain Zenatti

Mettre des mots sur ce qui vous freine

J'ai préparé 5 questions. Elles prennent 2 minutes. Vous obtenez tout de suite un décryptage personnalisé : ce qui ressort de vos réponses, et quelques pistes pour la suite. C'est gratuit, sans engagement, et vos réponses restent confidentielles.

Faire mon décryptage

Si vous préférez en parler directement, je vous propose un échange de 15 minutes par téléphone, gratuit. On regarde ensemble si l'hypnose est adaptée à votre situation. Si elle ne l'est pas, je vous le dis.

resalib.fr/p/47325

novahypnose.fr/wa

06 49 35 80 89

contact@novahypnose.fr

16 rue Saint-Antoine, 75004
Paris

Alain Zenatti
Hypnothérapeute

SOURCES ET LIMITES

D'où viennent *les chiffres*

Sources citées

- Berglas S., Jones E. E. (1978), *Drug Choice as a Self-Handicapping Strategy in Response to Noncontingent Success*, *Journal of Personality and Social Psychology* 36(4):405-417.
- Bravata D. M. et al. (2020), *Prevalence, Predictors, and Treatment of Impostor Syndrome: A Systematic Review*, *Journal of General Internal Medicine* 35(4):1252-1275. texte
- Clance P. R., Imes S. A. (1978), *The Imposter Phenomenon in High Achieving Women*, *Psychotherapy: Theory, Research and Practice* 15(3):241-247.
- Clance P. R. (1985), *The Impostor Phenomenon*, Peachtree Publishers.
- Hartland J. (1971), *Further Observations on the Use of "Ego-Strengthening" Techniques*, *American Journal of Clinical Hypnosis* 14:1-8.
- Horner M. (1968), thèse doctorale, Université du Michigan (concept historique, révisé par la recherche ultérieure).
- Jiang H., White M. P., Greicius M. D., Waelde L. C., Spiegel D. (2017), *Brain Activity and Functional Connectivity Associated with Hypnosis*, *Cerebral Cortex* 27(8):4083-4093.
- Lavertue N. E., Kumar V. K., Pekala R. J. (2002), *The Effectiveness of a Hypnotic Ego-Strengthening Procedure for Improving Self-Esteem and Depression*, *Australian Journal of Clinical and Experimental Hypnosis* 30(1):1-23.
- Neff K. D. (2003), *Self-Compassion: An Alternative Conceptualization of a Healthy Attitude Toward Oneself*, *Self and Identity* 2(2):85-101 ; Neff K. D. (2023), *Annual Review of Psychology* 74:193-218.
- Steel P. (2007), *The Nature of Procrastination*, *Psychological Bulletin* 133(1):65-94.
- Ipsos, baromètre Qualisocial (enquête du 3 au 9 décembre 2024, 3 000 salariés), santé mentale des salariés en France.
- Young V. (2011), *The Secret Thoughts of Successful Women*, Crown Business.

LIMITES

Ce guide propose des pistes de réflexion. Il ne remplace ni un avis médical ni un suivi psychologique ou psychiatrique. Là où la recherche sur l'hypnose et le syndrome de l'imposteur ou l'auto-sabotage reste limitée, le guide le signale plutôt que d'extrapoler.